

TEMA 2.11 • GINECOLOGÍA

Tumor Ovárico (Tumor Anexial)

PERFIL EUNACOM 2.01.1.076

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Tumor Ovárico (Tumor Anexial)

1. Enfrentamiento General

Riesgos a evaluar: (1) Malignidad (cáncer) y (2) Torsión ovárica.

Examen inicial: Ecografía transvaginal (ETV).

Signos de Malignidad en ETV

TABLA 2.11.1: SIGNO VS INTERPRETACIÓN	
SIGNO	INTERPRETACIÓN
Sólido o sólido-quístico	Sospecha de cáncer
Tabiques o excrecencias internas	Sospecha de cáncer
Ascitis	Metástasis peritoneales → mal pronóstico

Algoritmo de Manejo

TABLA 2.11.2: HALLAZGO VS CONDUCTA	
HALLAZGO	CONDUCTA
< 5 cm, aspecto benigno	Observación ± ACO (facilitan regresión de funcionales) + seguimiento ETV
5–10 cm, no responde a ACO en 3 meses	Cirugía
> 10 cm	Cirugía de inmediato (alto riesgo de torsión)
Aspecto maligno o CA-125 > 35 U/L	Cirugía

CA-125 > 35 U/L = marcador de cáncer de ovario (no 100% específico; también sube en endometriosis).

Cirugía

- Vía laparoscópica preferentemente
- Mujer joven → **tumorectomía** (conservadora, preserva ovario)
- Postmenopáusica → **anexectomía**
- Biopsia rápida intraoperatoria → si cáncer: cirugía radical (histerectomía + salpingooforectomía bilateral + peritoneo)

2. Cáncer de Ovario

Factores de riesgo: Antecedentes familiares (BRCA1/2), nuliparidad.

Factor protector: ACO (bloquean estimulación ovárica).

Clínica: Asintomático o dolor abdominal vago (se confunde con SII) + ascitis.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Mujer > 60 años con "dolor abdominal tipo SII" sin causa GI clara → pensar cáncer de ovario.

Tratamiento: Cirugía citorreductora + quimioterapia (tumores quimiosensibles).

3. Lesiones Anexiales Funcionales

Quiste Folicular

- Folículo persistente, aspecto benigno en ETV (quiste simple) - Tratamiento: **observación** ± ACO si persiste

Cuerpo Lúteo

- Normal en fase lútea y embarazo temprano (hasta ~semana 10–12) - ETV: puede verse sólido-quístico (no es signo de malignidad en edad fértil/embarazo) - Tratamiento: **observación**

NOTA CLÍNICA

El aspecto sólido-quístico en ETV en mujer joven en edad fértil → pensar cuerpo lúteo, NO cáncer. El cáncer de ovario es en postmenopáusicas o en niñas (premenarquia).

4. Teratoma Ovárico

- Mujer **joven**, en edad fértil
- ETV: lesión sólida heterogénea (puede contener pelo, dientes, sebo)
- Variante quística benigna: **teratoma quístico maduro (quiste dermoide)**
- No regresa espontáneamente
- Tratamiento: cirugía siempre** (riesgo de torsión ovárica — se ha preguntado en EUNACOM en contexto de teratoma)

5. Síndrome de Meigs

- Tríada:**
- Fibroma ovárico** (tumor benigno sólido homogéneo)
- Ascitis**
- Derrame pleural**

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Diferencial clave: Tumor + ascitis → sospechar cáncer de ovario. PERO tumor de **aspecto benigno** + ascitis + derrame pleural → **Síndrome de Meigs** (benigno).

Tratamiento: Resección quirúrgica del fibroma → resolución de ascitis y derrame.

6. Endometrioma Ovárico

- Causa:** Endometriosis que invade el ovario → quiste ("chocolate")
- Clínica:** Dismenorrea secundaria intensa y progresiva
- CA-125:** Puede estar elevado (no específico de cáncer)
- ETV:** Quiste homogéneo con contenido hipoeoico en "vidrio esmerilado"
- Tratamiento: Cirugía** (indicación absoluta — no responde bien al tratamiento médico)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 58 años, posmenopáusica, consulta por distensión abdominal progresiva de 3 meses. Ecografía transvaginal muestra masa ovárica derecha de 8 cm, con componente sólido y líquido, tabiques gruesos y vascularización al Doppler. CA-125: 210 U/mL (VN <35). ¿Cuál es la conducta más apropiada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tumor Ovárico (Tumor Anexial). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- 1. Enfrentamiento General
- Signos de Malignidad en ETV
- Algoritmo de Manejo
- Cirugía
- 2. Cáncer de Ovario
- 3. Lesiones Anexiales Funcionales
- Quiste Folicular

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TUMOR OVÁRICO (TUMOR ANEXIAL))**PREGUNTA 1**

Mujer de 58 años, posmenopáusica, consulta por distensión abdominal progresiva de 3 meses. Ecografía transvaginal muestra masa ovárica derecha de 8 cm, con componente sólido y líquido, tabiques gruesos y vascularización al Doppler. CA-125: 210 U/mL (VN <35). ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Observación con ecografía de control en 6 meses
- B)** Aspiración del quiste guiada por ecografía
- C)** Derivación a oncología ginecológica para laparotomía exploradora y estadificación
- D)** Tratamiento con anticonceptivos orales por 3 meses y reevaluar
- E)** PET-CT para estadificación antes de cualquier intervención

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Tumor Ovárico (Tumor Anexial)?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Tumor Ovárico (Tumor Anexial). Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: TUMOR OVÁRICO (TUMOR ANEXIAL)

Factores de riesgo: Antecedentes familiares (BRCA1/2), nuliparidad. Factor protector: ACO (bloquean estimulación ovárica). ::tip Perla EUNACOM: Mujer > 60 años con "dolor abdominal tipo SII" sin causa GI clara → pensar cáncer de ovario. :::note El aspecto sólido-quístico en ETV en mujer joven en edad fértil → pensar cuerpo lúteo, NO cáncer. El cáncer de ovario es en postmenopáusicas o en niñas (premenarquia). :::